

CASO DE ESTUDIO Nº 2: "EL DERRUMBE DE CARLOS"

Asignatura: Intervención en Crisis **Unidad:** 1 - Fundamentos y Primera Instancia

I. Contexto Previo (Funcionamiento Pre-Crisis)

Carlos es un ingeniero industrial de 48 años que ha trabajado durante 20 años en una multinacional automotriz. Su identidad personal está fuertemente fusionada con su rol profesional: se define a sí mismo como "el proveedor", "el gerente" y "el hombre fuerte". Es padre de dos adolescentes (15 y 17 años) y su esposa se dedica al hogar.

Su estilo de afrontamiento habitual es el control y la autoridad. No suele compartir sus emociones ("eso es de débiles") y maneja el estrés trabajando horas extra. No tiene antecedentes de consumo de sustancias ni patologías previas, aunque es hipertenso controlado.

II. El Suceso Precipitante

El lunes por la mañana, Carlos fue citado a recursos humanos. Sin previo aviso, le notificaron que, debido a una fusión corporativa, su puesto desaparecía. Le dieron una caja para sus cosas y fue escoltado a la salida por seguridad en menos de 30 minutos.

El impacto fue un golpe directo a su narcisismo y a su seguridad básica. Carlos no regresó a casa. Se fue a un bar y apagó el celular. Apareció en su casa a las 3:00 AM, ebrio y gritando.

III. Estado de Crisis (72 horas después)

La esposa de Carlos llama a una línea de crisis (o solicita un psicólogo de emergencia) porque la situación en casa se ha vuelto insostenible y teme que él haga una locura. Al entrevistarlos, se observa el siguiente perfil **CASIC**:

1. **Conductual:** Aumento súbito y excesivo del consumo de alcohol (ha estado ebrio 3 días seguidos). Conductas de agresividad verbal hacia su esposa e hijos ("Ustedes no saben lo que es trabajar", "Son unos parásitos"). Rompió un espejo de un puñetazo. Insomnio global (no ha dormido).
2. **Afectiva:** Predomina la **Ira** y la **Humillación**. No hay llanto, sino furia explosiva. Debajo de esa ira, se percibe un terror intenso al futuro y vergüenza ("¿Cómo voy a mirar a mis amigos a la cara?").
3. **Somática:** Su presión arterial está peligrosamente alta (ha dejado de tomar su medicación). Refiere una gastritis severa ("fuego en el estómago") y tensión muscular rígida en mandíbula y puños.
4. **Interpersonal:** Aislamiento social total. Ha rechazado las llamadas de sus ex-compañeros. En casa, la dinámica ha cambiado de "padre proveedor" a "amenaza impredecible". Sus hijos se encierran en sus cuartos por miedo. Carlos proyecta su frustración en su familia, culpándolos de sus gastos.

5. **Cognoscitiva:** Pensamiento catastrófico y dicotómico (Todo o Nada): "A mi edad nadie me va a contratar", "Mi vida se acabó", "Soy un fracasado inservible". Tiene ideas paranoides sobre la empresa ("me lo hicieron a propósito para humillarme").

IV. Evaluación de Riesgo y Mortalidad

Al aplicar el Paso 2 de los PAP (Dimensiones del Problema), usted indaga sobre el riesgo.

Carlos dice: *"Mire, yo no soy un cobarde para suicidarme, pero le juro que si tuviera un arma iría a la oficina y haría que se arrepientan de haberme echado"*.

Existe un riesgo **Hetero-agresivo** (hacia otros) moderado, potenciado por el consumo de alcohol (desinhibidor). Aunque niega ideación suicida activa, el consumo de alcohol y la hipertensión no tratada representan un riesgo físico inminente.

V. Intervención de Primera Instancia

Dada la agresividad y el estado de intoxicación leve al momento de la entrevista, el interventor adopta una **Actitud Directiva**:

1. **Contacto:** Validar la injusticia que siente ("Entiendo que siente que le robaron 20 años de vida, es una traición terrible"), lo cual baja su defensa agresiva.
2. **Soluciones Inmediatas:** No se habla de buscar trabajo aún. La meta es la seguridad física. Se acuerda un "cese al fuego" con el alcohol por 24 horas.
3. **Acción:** Se contacta a su hermano (figura de autoridad que él respeta) para que se quede en la casa esa noche como contención externa. Se asegura que retome su medicación hipertensiva.